RECOMENDACIONES TRAZADORAS

A continuación se presentan de manera resumida las recomendaciones trazadoras adaptadas de la Guía para la Atención Clínica Integral del Paciente con Dengue y del Algoritmo Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de Dengue del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, ajustadas al contexto y a los procesos asistenciales de nuestra institución, con el fin de orientar una atención oportuna, estandarizada y basada en la evidencia.

Recomendación 1: Realizar identificación de paciente con sospecha de dengue.

¿Quién? – Responsable: Médico tratante

¿Cómo? – Acciones:

Registrar en la historia clínica:

- Antecedente de residencia o viaje a zona endémica en los últimos 14 días.
- Tiempo de evolución de la fiebre.
- Presencia de dos o más manifestaciones compatibles:
    - Cefalea.
    - Dolor retroocular.
    - Mialgias.
    - Artralgias.
    - Exantema.
    - Náuseas o vómito.
    - Leucopenia.

EN CASO PROBABLE DE DENGUE:

- Si síntomas < de 5 días: Indicar Dengue AgNS1 CUPS: 906305
- Si síntomas > o igual de 5 días: Indicar Dengue IgM CUPS: 906208

Recomendación 2: Identificar y documentar sistemáticamente los signos de alarma.

¿Quién? – Responsable: Médico general, urgencias y hospitalización.

¿Cómo? – Acciones:

Verificar y registrar la presencia o ausencia de:

- Dolor abdominal intenso o continuo.
- Vómitos persistentes.
- Sangrado de mucosas.
- Acumulación de líquidos (ascitis o derrames).
- Letargo o irritabilidad.
- Hipotensión postural.
- Hepatomegalia mayor de 2 cm.
- Incremento progresivo del hematocrito.

Todo paciente con uno o más signos de alarma debe clasificarse como dengue con signos de alarma y requerir observación intrahospitalaria.

Recomendación 3: Realizar hidratación temprana y adecuada según la clasificación clínica.

¿Quién? – Responsable: Médico tratante.

¿Cómo? – Acciones:

- Grupo A: Hidratación oral y manejo ambulatorio.
- Grupo B1: Hidratación oral supervisada y observación.
- Grupo B2: Inicio de líquidos intravenosos con cristaloides.
- Grupo C: Reanimación inmediata con líquidos intravenosos y manejo en unidad de mayor complejidad.

No retrasar la hidratación por ausencia de resultados de laboratorio.

(VER RUTA CLÍNICA INSTITUCIONAL)

Recomendación 4: Solicitar y realizar seguimiento con hemograma y hematocrito.

¿Quién? – Responsable: Médico general, urgencias y hospitalización.

¿Cómo? – Acciones:

- Solicitar hemograma según clasificación clínica.
- Comparar evolución del hematocrito y recuento plaquetario.
- Identificar oportunamente:
    - Hemoconcentración.
    - Trombocitopenia progresiva.
    - Leucopenia.

La interpretación de estos resultados debe orientar las decisiones de manejo y seguimiento.

Recomendación 5: Brindar educación al paciente y su familia sobre signos de alarma y seguimiento.

¿Quién? – Responsable: Médico y personal de enfermería.

¿Cómo? – Acciones:

Antes del egreso o manejo ambulatorio:

- Explicar signos de alarma.
- Indicar adecuada hidratación oral.
- Recomendar uso de acetaminofén como antipirético.
- Evitar AINES, aspirina e inyecciones intramusculares.
- Informar signos que obligan a reconsulta inmediata.
- Programar seguimiento clínico según evolución.

(VER RUTA CLÍNICA INSTITUCIONAL)

Recomendación 6: Verificar cumplimiento de criterios de alta hospitalaria.

¿Quién? – Responsable: Médico tratante.

¿Cómo? – Acciones:

Confirmar:

- Ausencia de fiebre durante 48 horas sin antipiréticos.
- Mejoría clínica evidente.
- Estabilidad hemodinámica.
- Diuresis adecuada.
- Ausencia de dificultad respiratoria.
- Ausencia de sangrado.
- Tendencia ascendente de plaquetas.

Todos los criterios deben quedar registrados en la historia clínica antes del egreso hospitalario.

(VER RUTA CLÍNICA INSTITUCIONAL)